

Objectifs et responsabilités dans la gestion des crises sanitaires

Une analyse des documents stratégiques

De nombreuses voix se sont élevées contre la gestion de la pandémie de Covid19 en France. Ces critiques émanent aussi bien du corps médical que de certains élus ou des pompiers. C'est au fond, une organisation et une stratégie qui sont contestées. L'une pour son côté fortement centralisé, rigide, et top peu articulé sur les médecins libéraux et les pôles de compétences régionaux (CHU), l'autre pour sa logique médicale, moins fondée sur le couple diagnostic-soin que sur les contraintes de la gestion des urgences, et d'une recherche considérée comme « hors-sol ».

Je me suis donc demandé comment, dans les documents « stratégiques » de la mission « santé » de l'Etat, était conçue, « verbalisée », et organisée la prévention et la gestion des risques sanitaires, et singulièrement épidémiques. Cette lecture éclaire sans aucun doute le sentiment qui a pu apparaître assez tôt d'une impréparation et d'une inefficacité, dont on peut craindre qu'elles expliquent au moins partiellement le taux de létalité (CFR) des personnes atteintes de Covid19. L'absence de clarté tant des objectifs que des responsabilités, et celle d'indicateurs précis est ici en cause.

C'était avant...

Dans les années 1973-1978 j'ai eu à mettre en place, mais aussi enseigner, les méthodes de « Rationalisation des Choix Budgétaires - RCB » (version française révisée du Planning Programming Budgeting System - PPBS - américain, lancée en 1968 par Michel Debré).

Adéquation moyens-objectifs

Quelle était la principale innovation de ces méthodes pour l'Etat ?

C'était de relier de manière cohérente les objectifs poursuivis et les programmes, moyens et donc budgets mis en oeuvre. Au lieu de définir des priorités vagues déclinées à coup de budgets alloués, on cherchait alors à reconstruire dans un appareil d'Etat complexe une adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre. Et encore faut-il rappeler ici qu'on avait alors un « Plan » qui, pour les grandes priorités nationales fixait non seulement les orientations, mais définissait leur mise en oeuvre. La RCB était donc un maillon de plus, articulant les budgets et les actions au niveau supérieur de la planification nationale, et se donnant les moyens de suivre, d'analyser, de corriger la mise en oeuvre annuelle de programmes pluriannuels.

Les programmes déclinaient ainsi des lignes d'action ou d'intervention prioritaires, et décrivaient au moyen d'indicateurs leur propre vie :

- indicateurs d'impact (mesurant l'impact du programme sur les objectifs poursuivis)
- Indicateurs de réalisation (mesurant la « production » du programme »)
- Indicateurs de résultats (mesurant les conséquences des réalisations)

- Indicateurs de moyens (mesurant les moyens alloués, soit directement par la puissance publique, soit par des partenaires, donc « hors budget »).

De mémoire, cette opération dans le domaine de la santé a permis de définir de grands programmes comme la périnatalité, ou le dépistage du cancer du col de l'utérus, ou dans le domaine des transports, celui de la sécurité routière.

Ah, j'oubliais, la RCB avait à la fois vocation à traiter de l'ensemble de l'activité de l'Etat, mais définissait aussi des programmes finalisés, comme ce fût le cas avec la sécurité routière.

Cette opération de RCB a été progressivement vidée de son contenu et abandonnée à la fin des années 1970, en même temps que le Plan a été amoindri. La Gauche en 1981 eu beau réhabiliter ce dernier, elle ne revint pas sur l'abandon de la RCB, misant essentiellement sur les « contrats de plan ». L'alternance eu raison de ce sursaut, faisant disparaître progressivement le Plan et la RCB, et leurs outils (méthodes, équipes, moyens) de construction et de mise en oeuvre.

Aujourd'hui : où sont passés les indicateurs

Dans l'affaire de la gestion des stocks stratégiques de masques de protection, il saute immédiatement aux yeux, que les différents indicateurs, qui décrivent la mise en oeuvre concrète des orientations générales du ministère, n'ont jamais été ni portés à la connaissance du ministre en charge, ni même peut-être produits (Audition d'Agnès Buzyn, Assemblée Nationale), et donc discutés. D'où cette question : que les moyens ne soient pas définis avec précision n'empêche nullement la définition d'objectifs, d'orientations et de lignes d'action permettant concrètement de déterminer en conséquence les moyens alloués. En d'autres termes, il faut s'intéresser alors aux objectifs assignés qui devraient figurer dans le « jaune » budgétaire (voir : <https://www.vie-publique.fr/fiches/la-loi-organique-relative-aux-lois-de-finances-lolf>), qui est un lointain écho des « Budgets de Programmes » des années 1970.

Le grand vide des objectifs dans le « jaune budgétaire »

Plongeons nous donc dans le « jaune » de la « mission santé ». Celle-ci est présentée ainsi : *« La mission « Santé » se compose de deux programmes placés sous l'autorité de la ministre des solidarités et de la santé. Il s'agit d'une part du programme 204, relatif à la prévention, à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins, sous la responsabilité du Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, et d'autre part du programme 183, qui traite de la protection maladie, sous la responsabilité de Madame Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la sécurité sociale. »* (Annexe au projet de loi de finances pour 2020, Santé).

Pour ce qui est du contenu, au stade général des objectifs, le ministère se contente de fournir deux indicateurs, le *sentiment des citoyens d'être en bonne santé* (donc un indicateur subjectif d'état de santé perçue) et l'*espérance de vie « en bonne santé »*, ces deux indicateurs n'étant rétrospectivement pas ou mal chiffrés, et ne présentant aucune perspective, donc aucun objectif concret. Frustrant donc.

Indicateur : Espérance de vie (du point de vue du citoyen)							
	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2020 Prévision	2022 Cible
Espérance de vie en bonne santé à la naissance			NC				
1. Hommes	année	62,6	NC	ND			
2. Femmes	année	64,1	NC	ND			
Espérance de vie en bonne santé à 65 ans			NC				
1. Hommes	année	ND	NC	ND			
2. Femmes	année	ND	NC	ND			

A ce stade, peut-être doit-on s'interroger sur le choix de ces indicateurs et leur intérêt, et sur la publication d'un tableau très vide (ni prévision, ni cible !)... Du coup, le ministère se trouve ainsi sans objectif mesuré.

Les crises sanitaires

Le programme 204 retient bien, parmi ses axes principaux, l'amélioration de la gestion des crises sanitaires et des situations d'urgence. Mais le commentaire qui explicite cet axe concerne essentiellement les systèmes d'information et l'intelligence artificielle. On sent ici qu'implicitement l'attention est tournée essentiellement vers la menace terroriste, et le suivi des victimes.

D'ailleurs les indicateurs de « performance » retenus concernent essentiellement ... la distribution d'eau potable, et le traitement de signalements.

A vrai dire on ne retrouve aucun élément concernant directement la gestion de crises pandémiques comme celle de 2020.

Mais on découvre précisément qu'en 2020 trois mesures ont impacté le programme 204, à savoir le transfert de l'Etat à l'Assurance Maladie, du financement de l'agence nationale de santé publique (autrement appelée Santé Publique France), ainsi que celui de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, et de l'accompagnement des groupes hospitaliers territoriaux dans le cadre du programme « Phare » de performance des achats hospitaliers. *Un transfert global de plus de 270 millions €.*

Contrat d'objectifs sans objectifs ?

Nous nous sommes donc dit qu'il fallait donc s'intéresser à Santé Publique France et au contrat d'objectif qu'il a signé avec l'Etat (voir plus bas). Ce contrat d'objectifs et de performance (COP) a été conclu pour 2018-2022, et « s'inscrit dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé, et le projet stratégique de la Direction Générale de la Santé (2017-2019) ». Malheureusement, la stratégie nationale demeure définie de manière fort vague, et demeure au niveau des grandes orientations.

La DGS

Le Plan stratégique de la DGS est plus intéressant. Il précise en effet la nécessité d'améliorer la connaissance des risques et des dangers, y compris par la veille internationale, le renforcement des moyens de détection précoce, et d'insérer l'expertise au coeur de la gestion. La question c'est bien entendu de savoir comment...

C'est à ce niveau qu'est effectivement préfiguré le dispositif qui a été utilisé en 2020, avec le rôle de la coordination du système d'agence, et renforcement des liens avec le consortium REACTing (<https://reacting.inserm.fr/our-role/>).



Dans les prochaines années, il sera donc nécessaire de :

- **Limiter** les risques d'endémisation et d'épidémisation par une surveillance et des contre-mesures adaptées à ce type de pathologies dites « tropicales »
- **Organiser** la surveillance entomologique et prévenir l'implantation et le développement des moustiques vecteurs, en lien étroit avec les collectivités territoriales
- **Renforcer** la prévention des maladies vectorielles par une meilleure information du public et des professionnels de santé notamment sur les mesures d'hygiène

On notera également dans le texte le rôle majeur que doit jouer la modélisation.

La question centrale de l'amélioration des modalités de recours à l'expertise est justement posée, mais sans s'interroger profondément sur l'organisation et la place de la recherche en situation de crise. L'affirmation conclusive du projet laisse en effet quelque peu rêveur : « *Les conclusions des expertises réalisées doivent systématiquement permettre d'identifier les incertitudes et les limites des connaissances disponibles. Le choix des modalités d'action les plus probantes en matière d'efficacité sanitaire, sociale et économique doit pouvoir s'appuyer sur la synthèse des connaissances disponibles sur des interventions déjà mises en œuvre, dans le cadre d'un partenariat à construire entre les agences sanitaires, l'EHESP, la HAS ou encore la Société française de santé publique (SFSP)* ».

On regrette naturellement l'imprécision des choses, et le caractère incantatoire du propos. Sans doute peut-on aussi souligner l'absence de référence aux médecins de première ligne et à leur expérience ainsi qu'au rôle des CHU, de même, qu'à ce stade, à la question des moyens.

Le contrat (COP) avec Santé Publique France

Revenons donc au contrat liant l'Etat à Santé Publique France. Outre les objectifs de surveillance épidémiologique et de veille sanitaire, la préparation et la réponse aux menaces figure au rang des grands objectifs. C'est sous cette rubrique que s'insère la question des masques (et sans doute de la politique de test).

Concernant la réserve sanitaire et les stocks de produits de santé, l'action de Santé publique France s'organisera autour de la mise en œuvre des cadres d'emploi actualisés, et, à partir de là, de quelques grands objectifs : la prise en compte d'enjeux spécifiques à certaines situations d'urgence sanitaire, en particulier Outre-mer ; le renforcement de la capacité d'appui aux ARS, notamment dans la gestion des stocks tactiques ; la recherche de la plus grande efficacité possible dans la gestion de ces dispositifs, qu'il s'agisse de travailler à la complémentarité entre les différents dispositifs de réserve opérationnelle, ou d'alimenter la réflexion sur l'adéquation aux besoins de la composition des stocks stratégiques et sur l'optimisation possible de leurs modalités d'achat et de gestion.

C'est donc bien l'établissement qui a la charge des stocks stratégiques, et même si l'on en croit la rédaction imprécise du texte, à les définir. Au rang des objectifs opérationnels, Santé publique France est chargée de « *contribuer à une utilisation efficiente des stocks stratégiques et tactiques* », et doit produire un rapport en 2020 et 2022 sur le sujet.

Autrement dit, en 2020 il n'y a pas d'autre objectif précis. Le seul document récent le sujet étant une expertise datant de mai 2019 intitulée « *Avis d'experts relatifs à la stratégie de constitution d'un stock de contre-mesures médicales face à une pandémie grippale* ». Cet avis nous laisse également sur notre faim. Très sommaire sur les masques et sur les procédures, il ne formule guère d'orientations, et laisse transparaître des doutes sur l'utilité des masques pour la population.

Aucun indicateur chiffré n'apparaît donc dans le « COP ». Il est même frappant dans ce document de constater que les indicateurs retenus sont pour l'essentiel la production de rapports.

On peut donc considérer que la délégation de la gestion des stocks stratégiques à Santé Publique France, consiste effectivement à lui en remettre la responsabilité tout en lui demandant un examen de la doctrine d'emploi et de maintien. Autrement dit, il n'y a pas, en 2020, de doctrine claire ni d'objectif. Comme manifestement il n'en existe pas face à une nouvelle pandémie.

Ce court examen des textes « structurant » la stratégie française, ou en tous cas l'explicitant, ne permet pas seulement de comprendre l'imprécision totale des objectifs en matière de masques, et plus généralement les principes directeurs de l'organisation de la lutte contre une éventuelle épidémie « nouvelle ». Il semble bien révéler comment l'abstraction s'est emparée d'un domaine si essentiel.

